EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	: HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	: 85279
SERVICIO	: MEDICINA HSC		
FECHA	: 2024-05-26 08:35:00		

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: HILDA DE LAS MERCEDE LAGOS MARDONES			**RUN**	: 5.728.740-3
F.Nac	: 28-12-2021	**Edad**	: 2 AÑOS, 4 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	:			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-05-23	**Fecha Egreso**	: 2024-05-26 08:35:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J11.8-INFLUENZA CON OTRAS MANIF., VIRUS NO IDENTIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Neumonía Viral por influenza A sobreinfecatada en resolución
HTA
DM nir
Enfermedad renal crónica sobre aki resuelta

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J15.9-NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina de 77 años autovalente, con antecedentes mórbidos de ASMA- HTA- ARTROSIS en tto. Sin alergia conocidas. Acude al servicio de urgencia el 19/05/24 por cuadro de 48 hrs de evolución, caracterizado por odinofagia, mialgias, cefalea, se otorga tto y alta a domicilio por cuadro respiratorio. Se agrega por cuadro febril, calosfríos, CEG, decaimiento, por lo que acude nuevamente urgencia, a la llegada GLS 15, vigil orientada en T-E, al CSV febril, el resto dentro de rangos, al examen fisico, regular hidratación, PIRRL, yugulares planas, ventilando espontaneo, requerimientos de O2, con leve uso de musculatura accesoria subcostal, llene capilar conservado, piel tibia, durante la atención, presenta Lipotimia, se realiza exámenes de laboratorio-> glicemia 107; crea 1,8 (prev 1,2), ac urico 5,4; LDH 199; lactato 3,4; PCR 19,2; uremia 95; BUN 44; Na/K/Cl 138/4.2/114; INR 1,11; GSA pH 7,34; influenza A positivo, influenza B sincicial y covid (-).
Rx de torax cardiomegalia e infiltrados para hiliar derecho. PaFi= 354 mmHg , se titula oxigeno con fio2 28% por lo que se ingresa. evolucionando .
presenta un CON CUADRO DE DEPOSICIONES LÍQUIDAS, SIN SANGRE se solicita Adenovirus : Negativo Leucocitos Fecales : Negativo Rotavirus : Negativo. Exámenes control: Glicemia : 179 Creatinina : 1,40 * mg/dl LDH : 216 U/L Clearence Calculado(MDRD) : 36,37 Lactato : 2,3 Proteina C Reactiva : 223,6 Sodio (Na) : 141,00 mmol/L Potasio (K) : 3,50 mmol/L Cloro (Cl) : 120,00 Hemoglobina : 11,0 g/dl Hematocrito : 33,0 o/o Recuento de leucocitos : 13,90 * mil/ul Recuento Hematies : 3,43 * Mill/ul Plaquetas : 136 * Segmentados : 78 * o/o 43 – 77. Linfocitos : 14. Procalcitonina : 6,08 pH : 7,34
Paciente Hemodinamia Estable, Hidratada, Yugulares Planas, Afebril, Taquicárdica, Normotensa, Con Sat 90% Ambiental. Sin Dolor, Sin Episodios De Nauseas Y/O Vómitos, Sin Sin Diarrea Desde

Hace 24 Horas . Pcr Al Alza. Con Buena Tolerancia A Alimentación Vo. Diuresis (+).
control de laboratorio pcr 144, procalcitonina 2,6 ya en mejores condiciones para ser ingresada al servicio de hospitalización domiciliaria para continuar tto medico – kine.

PLAN DE MANEJO:

Reposo Relativo Asistido
Reposo Relativo Asistido
Régimen Liviano Hiposódico - Diabético
Omeprazol 20 Mg Dia Vo

Bromuro Ipratropio 4 Puff Cada 6 Horas
Salbutamol 2 Puff C/8hrs
Paracetamol Amp 1 Gr Cada 8 Horas Sos Fibre Vo
Prednisona 20 Mg Cada 24 Horas Vo
Azitromicina 500 mg dia vo por 3 dias
Ceftriaxona 2 gr dia por 6 dias ev
Kine Respiratoria Por 2 Veces
continuar Con Tto Crónico
Avisar Eventualidad

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo Relativo Asistido
2. Reposo Relativo Asistido
3. Régimen Liviano Hiposódico - Diabético
4. Omeprazol 20 Mg Dia Vo
5. Bromuro Ipratropio 4 Puff Cada 6 Horas
6. Salbutamol 2 Puff C/8hrs
7. Paracetamol Amp 1 Gr Cada 8 Horas Sos Fibre Vo
8. Prednisona 20 Mg Cada 24 Horas Vo
9. Azitromicina 500 mg dia vo por 3 dias
10. Ceftriaxona 2 gr dia por 6 dias ev
11. Kine Respiratoria Por 2 Veces
12. continuar Con Tto Crónico
13. Avisar Eventualidad

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO